جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : هند محمود عبدالقادر سعيد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** السيده زينب **العنوان :** 16 ش الشيخ - البغاله
رقم البطاقة : 27810010100783 **رقم التليفون :** 01127719111 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-10-1978 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هند محمود عبدالقادر سعيد
National ID: 27810010100783

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bilateral mammogram and breast ultrasound**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

طبع فى 16 06 2026 :58

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هند محمود عبد القادر سعيد

المحافظة : القاهره | الحي / المدينة : السيده زينب | العنوان : البغاله

رقم البطاقة : 27810010100783 | رقم التليفون : 01129029833 | تاريخ تسجيل الإستمارة : 16-06-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 01-10-1978 | المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي المقر بما فيه

التوقيع:(----------) التوقيع:(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج كيماوي تاكسول / كاربو | قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/ احمد نجيب الوظيفة: ---------- التوقيع: ----------

الاسم: د/ خالد عبدالعزيز الوظيفة: ---------- التوقيع: ----------

الاسم: د/ محمد الكيلاني الوظيفة: ---------- التوقيع: ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات الواقعة
رئيس المجلس الطبي المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- ا.د/ ---------- د/ ---------- د/ ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------

خطة العلاج : ----------

المستشفي : ----------قسم : ----------

جهة العلاج : ----------نفقات : ----------

ملاحظات : ----------

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Entered by: 266 On: 2026-06-11

Name:	هند محمود عبدالقادر سعيد
MR. :	9855

GUSTAVE ROUSSY

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد..

ابداء للطلب المقدم من

بشان تقرير طبي للمريض

بقسم:

رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرا عن حالة

تاريخ وساعة الدخول: mm/dd/yyyy -- :-- --

تاريخ وساعة الخروج: mm/dd/yyyy -- :-- --

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

وره بالتدبين وتحتاج الى علاج كيماوي تاكسول و كاربوبلاتين

تحريرا في .

الوقت : --:-- --

التاريخ : 06/11/2026

الطبيب المعالج :

يعتمد ,

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Name: هند محمود عبدالقادر سعيد	
MR. : 9855	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		رقم طبي:	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

47YO FEMALE PT M:FREE S:CS ,BIL. REDUCTION MAMMOPLASTY (COSMETIC) BILATERAL BREAST CANCER IDC RT. LUMINAL A ER8/8,PR8/8,HER 2 +1,KI 67 10% LT. TNBC KI 67 90% BSM :ACR C RT.LOQ MASS 3*1.5CM WITH UOQ INFILTRATED PARENCHYMA .NO LNS CLINICALLY T2 NO MX LT>UIQ 3*2.2CM WITH 5CM ANT DUCTAL EXTENSION REACHING NIPPLE , 2 LEVEL 1 LNS CLINICALLY T2 N2 MX CT CAP REQUESTED THEN GO FOR CESM IF FREE

MDT >>> clips insertion BILAT for neoadj taxol/carbo weekly followed by AC 4 cycles with keytruda 8 cycles FOR CESM Post neodj WT 97 HT 170 today for W1 taxol 75 mg /m2 , carbo auc 2 labs >> OK C1 kytruda 200 mg + supp ttt W2 W3 TC >> pharmacy

6/2026 MDT : 1/clips insertion BILAT 2/ neoadj taxol/carbo weekly followed by AC 4 cycles with keytruda 8 cycles 3/ CESM Post neodj W2 TC W3 TC + W4 TC /KETRRUDA IN PH

for W4 TC .. labs pending, keytruda pending approval w5 and 6 pharmacy

clinical pharmacy intervention : low anc 1.3 last week for new cbc and it is 1.22 for c1 keytruda 200mg + w 5 taxol 150 mg carbo auc 2 + neupojen

prem bilateral breast cancer rt ct2 no mo idc 1 er8/8 pr5/8 her2-ve ki 10% lefty ct2 n1 mo idc 3 triple -ve ki 90% clips inserted (((brca 1 2 no mutation))) tlc 2.9/1.1 ast 54 alt 116 for w 7 taxol 150 carbopl auc 2 and 1 proph neupogen and liver support silymaryn 1x3

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	الوقت :	

الطبيب المعالج : ميار فؤاد علي فؤاد

يعتمد ,

٢٢
٢٥



DMS
كلاوى
صدرى



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

05/07/2026

MDT FORM

Name:	هـ محمود عبدالقادر سعيد	**MRN:**	9855
Age:	48 Y	**ID:**	27810010100783
Menopausal Sta		**Phone:**	
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
CO Morbidity:		**Reason Of MDT:**	

Clinical Data:

BX:

ER: lt 0/8 rt 8/8 **PR:** lt 0/8 rt m5/: **HER2:** lt -ve rt + **KI67:** lt90% rt :

Sonomammography:

CESM : RT OUTER CENTRAL MIDDLE THIRD HETEROGENOUS MODERATE ENHANCING LOGTIUDINAL LESION WITH INDISTINCT MARGINS 2.8*2.5*3.6 CM LOCATED 6.5CM FROM NIPPLE ,LESION SURROUNDED BY FAINT ENHANCING FOCI OCCUPY MOST OF OUTER HALF OF BREAST WITH OVERALL COVERAGE AREA OF PROCESS 8.6*3.3*9.9CM \NON PATHOLOGICAL LN LT BREAST UPPER CENTRAL THIRD ROUND MODERATE HETEROGENOUS ENHANCING LESION WITH INDISTINCT 3.4*2.8*3.1CM LOCATED 3.5CM FROM NIPPLE \ LEVEL 1 TWO PATHOLOGICAL LN LARGEST 2.4*1.8CM

Mets Workup:

History:

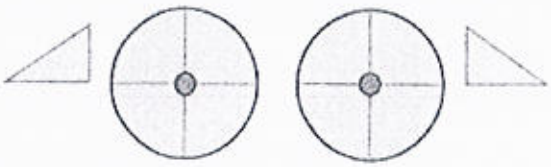
Recommendations:

FOR NACT +CLIP INSERTION ON LT BREAST LESION
THEN RT SM+SLNB
LT WLE+ALND VS SLNB ACCORDING TO RESPONSE

MDT Outcome & Plan

clips insertion BILAT
for neoadj taxol/carbo weekly followed by AC 4 cycles with keytruda 8 cycles
FOR CESM Post neodj

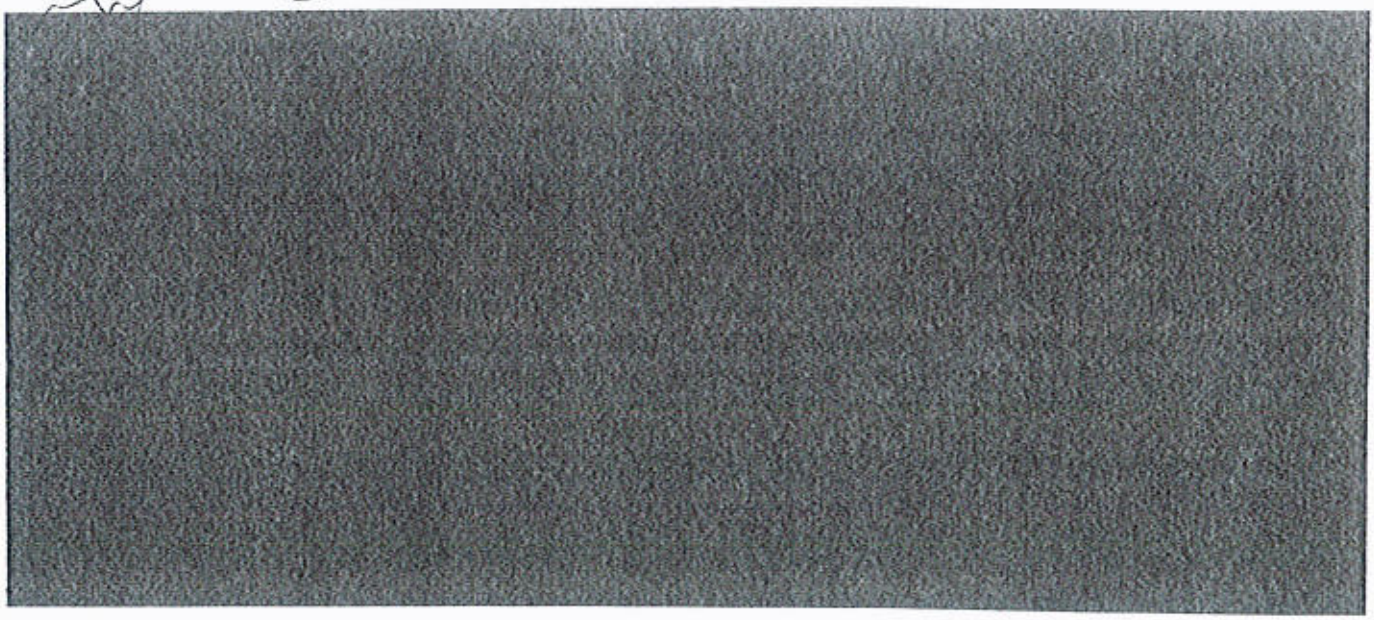
R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ حنان عزت	د/ أحمد نجيب				



GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name	: الأستاذه / هند محمود عبد القادر سعيد	Request No.	: 13005463
Patient No.	: 27810010100783	Request Date	: 15/03/2026
Path No.	: 717/26	Verification Date	: 23/03/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast (BIRADs 4c) suspicious lesion & Left breast (BIRADs 5) suspicious lesion with pathological axillary lymph node.
Nature of Specimen:
1- Right breast lesion, Tru-cut biopsy, collected on 15/03/2026, at 9:30 am, Cold ischemia time: 20 seconds.
2- Left breast lesion, Tru-cut biopsy, collected on 15/03/2026, at 9:46 am, Cold ischemia time: 20 seconds.

Gross Examination:
Two specimens were received as follow:
1- Right: Fragmented grey white tissue core, measured 1 cm long. Totally submitted.
2- Left: Four fragmented grey white tissue cores, the longest is 1.5 cm. Totally submitted.

Microscopic Examination:
1- Right breast mass:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade 1 (differentiation 1, nuclear pleomorphism 2, mitosis 1).
* Ductal carcinoma in situ: Absent.
* Angioinvasion: Absent.
* Perineural invasion: Absent.
* Microcalcification: Absent.

2- Left breast mass:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade 3 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 3, mitosis 2).
* Ductal carcinoma in situ: Absent.
* Angioinvasion: Present.
* Perineural invasion: Absent.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الأستاذه / هند محمود عبد القادر سعيد	Request No.	: 13005463
Patient No.	: 27810010100783	Request Date	: 15/03/2026
Path No.	: 717/26	Verification Date	: 23/03/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

* Microcalcification : Absent.

Diagnosis:
1- Right breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 1.

2- Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 3.

- For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / هند محمود عبد القادر سعيد	Request No.	: 13005463
Patient No.	: 27810010100783	Request Date	: 15/03/2026
Path No.	: 717/26	Verification Date	: 23/03/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed youss

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Right breast (BIRADs 4c) suspicious lesion diagnosed invasive duct carcinoma, Grade 1 & Left breast mass (BIRADs 5) diagnosed invasive duct carcinoma, Grade 3.
Nature of Specimen:
1- Right breast lesion, Tru-cut biopsy, collected on 15/03/2026 at 9:30 am, Cold ischemia time: 20 seconds.
2- Left breast lesion, Tru-cut biopsy, collected on 15/03/2026 9:46 am, Cold ischemia time: 20 seconds.

Technique:
- Sections were prepared from the paraffin blocks (1 & 2), processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
1- Right breast mass:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 10% of tumor cells (score 5/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 10%.

2- Left breast mass:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in 8% of tumor cells (Ultra-low, score 0+).
- Ki67%: 90%.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	الأستاذه / هند محمود عبد القادر سعيد	Request No.	13005463
Patient No.	27810010100783	Request Date	15/03/2026
Path No.	717/26	Verification Date	23/03/2026
Sex	Female	Financial Category	جوستاف روسي - مبادره
Age	47 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.			
		Registered by	.marwa mohamed youss

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Diagnosis:
1- Right breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 1.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 5/8).
- Her2: Low (Score 1+) .
- Ki67%: 10%.

2- Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma , Grade 3.
IPT:
- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Ultra-low, (score 0+).
- Ki67%: 90%.

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient ID: 95189	Patient Name English: Hend Mahmoud Abdalkader
Age: 48 years old	2026/05/05 11:49:21 AM :Report Date

9N00

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: A case of bilateral IDC , Grade I on the right side & Grade III on the left side.

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: mild background enhancement

ACR: C(Heterogeneously dense)

History of bilateral breast reduction surgery.

RIGHT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images:**
  1. outer central middle third indistinct area of distortion.
  2. Inner central posterior third oval circumscribed isodense lesion measures 0.7x0.3cm located 13cm from the nipple .(based on CC view)
  3. Scattered benign calcifications.
- **Recombined (Post contrast) images:**
- outer central middle third heterogenous moderate enhancing longitudinal lesion with indistinct margins measures 2.8x2.5x3.6cm located 6.5cm from the nipple(index lesion), the lesion is seen surrounded by faint enhancing foci extend anterior , posterior , superior and inferior to the index lesion (occupy most of the outer half of the breast). With overall coverage area of the process 8.6x3.3x9.9cm with the nearest focus located 3cm from the nipple .
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary US:**
  1. 8:00 middle third irregular hypoechoic mass with distortion(index lesion).
  2. 7:00 zone C irregular hypoechoic lesion
  3. The other enhancing foci **could not** be detected accurately by US
  4. 3:00 probably benign non enhancing lesion
  5. Non pathological axillary lymph nodes.

LEFT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images:** upper central middle third indistinct area of focal asymmetry.
- **Recombined (Post contrast) images** :upper central middle third nearly round moderate heterogeneously enhancing lesion with indistinct margins measures 3.4x2.8x3.1cm located 3.5cm from the nipple.
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary ultrasound:**
  1. 11-12:00 irregular hypoechoic lesion(index lesion)
  2. Level I discrete 2 pathologically enlarged lymphnodes the largest shows enlarged non uniform cortical thickness with indenting hilum, it measures 2.4x1.8cm with cortical thickness up 1.5cm

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	الأستاذه / هند محمود عبد القادر سعيد	Request No.	13005463
Patient No.	27810010100783	Request Date	15/03/2026
Path No.	717/26	Verification Date	23/03/2026
Sex	Female	Financial Category	جوستاف روسي - مبادره
Age	47 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.			
		Registered by	.marwa mohamed youss

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

IMPRESSION:

RIGHT BREAST:

1. (BIRADS6 = pathologically proved malignancy): outer central & outer half pathological enhancing process as described roughly extend from (7:00-10:00) as described
2. (BIRADS3= probably benign lesion) 3:00 probably benign non enhancing lesion

LEFT BREAST: (BIRADS 6= pathologically proved malignancy): upper central unifocal enhancing mass as described .

Best regards,

Dr. Marwa Ramzy. MD, FRCR,

Sonography
[[DOCTYPE:SONOGRAPHY]]

اسم الفرع السيدة زينب
مدير الفرع د. زينب ثاقب
مدير الوحده ا.د رانيا درويش
طبيب الوحده ا. د. علياء الدش

المختبر
al mokhtabar
moamena kamel lab
معامل مؤمنة كامل

رئيس مجلس الادارة
ا. د. مؤمنه كامل

مدير ا
ا. د. ني

PATIENT NAME			Registered	24-05-2026 15:18:41	Collected	24-05-2026 15: 5
هند محمود عبد القادر			Authenticated	15-06-2026 10:19:40	Printed	21-06-2026 12:48 43
Visit Number	Age	Gender	Referred By		Client ID	
20926506801	48 Year	Female	Prof : -		55452	

MOLECULAR BIOLOGY REPORT Report

BRCA 1.2 WHOLE GENE SEQUANCING / BLOOD (Astrazneca)

Result : No Pathogenic variants detected in *BRCA1* or *BRCA2* genes sequencing.

Background

- Hereditary Breast Cancer accounts for about 5-10% of female breast cancer and 4-40% of male breast cancer. The most common cause is mutations in the BRCA1 & BRCA2 genes which are tumor suppressor genes located on chromosomes 17 and 13 respectively.

- Pathogenic variants of these genes are inherited in an autosomal dominant manner and are associated with hereditary breast and ovarian cancer (HBOC) syndrome.
- HBOC syndrome increases the risk for breast (female and male), ovarian, fallopian tube, peritoneal, pancreatic, and prostate cancers. Additionally, BRCA2 carriers may be at increased risk for melanoma.

Method

- Genomic DNA was extracted from the patient's specimen. Libraries were prepared according to manufacturer's protocol then next-generation sequencing was performed on the Illumina MiSeq platform using CE-IVD BRaCA assay

- The assay analyzes sequencing of all exons and immediately adjacent intronic regions of BRCA1 & BRCA2 genes.

- Raw sequence data analysis, including base calling, demultiplexing, alignment to the hg19 human reference genome (Genome Reference Consortium GRCh37), and variant calling is done using standalone software. Variants are interpreted using publicly available databases such as Exac, GnomAD, dbSNP, ClinVar, Brca exchange. Variants are classified according to the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) guidelines.

- Benign and likely benign variants are not included in this report.

- Variants of unknown significance classification may change over time.

Limitations

- Large rearrangements may not be detected, variants in regions with high GC content or pseudogenes may give false negative or false positive results.

- The test result is for clinical reference and clinicians should interpret it in the context of the patient's condition, clinical

Rania Darwish.

Dr. Rania Darwish
Prof of Clinical & Chemical Pathology,
Faculty of Medicine, Cairo University

19014
almokhtabar.com
CAP ACCREDITED
حب نفسك

PATIENT NAME			Registered	24-05-2026 15:18:41	Collected	24-05-2026 15:19:15
هند محمود عبد القادر			Authenticated	15-06-2026 10:19:40	Printed	21-06-2026 12:48:43
Visit Number	Age	Gender	Referred By		Client ID	
20926506801	48 Year	Female	Prof : -		55452	

findings, family history, other lab investigations, and international guidelines for treatment.

References

- Yoshida, Reiko. "Hereditary breast and ovarian cancer (HBOC): Review of its molecular characteristics, screening, treatment, and prognosis." Breast Cancer 28.6 (2021): 1167-1180.

- Richards, Sue, et al. "Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology." Genetics in Medicine 17.5 (2015): 405-423.

Rania Darwish.

Dr. Rania Darwish
Prof of Clinical & Chemical Pathology,
Faculty of Medicine, Cairo University

19014
almokhtabar.com
CAP ACCREDITED